

Abortamento · tipos e conduta

Abortamento é a interrupção da gestação antes de 20–22 semanas (definição clássica de prova). O tipo clínico define: expectante/misoprostol/AMIÚ e, no infectado, ATB + esvaziamento.

Classificação rápida

Lembre - Classificação rápida

Ameaça: colo fechado, útero compatível, embrião vivo. Inevitável: colo dilatado, bolsa rota/sangramento. Completo: útero vazio após expulsão. Retido: óbito sem expulsão.

Triagem: colo fechado + vitalidade = ameaça; colo aberto + restos = incompleto; febre/dor = infectado — urgência.



Condutas-chave

- Tipagem ABO/Rh — imunoglobulina anti-D se Rh negativo conforme protocolo
- USG para vitalidade e restos
- Incompleto/retido: expectante, misoprostol ou AMIÚ/curetagem conforme estabilidade e preferência
- Infectado/séptico: ATB amplo + esvaziamento; UTI se choque

Quadro clínico

Tipo | Colo | USG / nota

Ameaça | Fechado | Embrião vivo

Inevitável | Aberto | Expulsão iminente

Incompleto | Aberto | Restos intracavitários

Completo | Fechado/fechando | Cavidade vazia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Abortamento infectado não se resume a antitérmico. Antibiótico EV e esvaziamento uterino são pilares — atraso aumenta risco de sepse e lesão reprodutiva.